

흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 | 총 5문제

2025년 Q25 [홍정희] 흉부질환 영상의학 소견 유형 분석

Q25. 25. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 악성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated 모양으로 나타난다.
 - 2) 악성 결절은 calcification을 보이지 않으므로 calcification이 보일 경우 양성 결절로 생각해야 한다.
 - 3) 양성 결절 석회화는 ecentric, stippled한 것이 특징적이다.
 - 4) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
 - 5) 악성 결절은 margin이 주로 lobulated, spiculated한 양상이며 크기가 2cm 이상으로 큰 것이 특징이다.
- 1) ~3)
- 석회화는 양성 결절에 더 흔히 나타나며, 양성 석회화 병변은 주로 diffuse, central, popcorn, laminated 모양을, 악성 결절 석회화는 주로 stippled, eccentric 모양을 보입니다.
- 4) 양성 결절은 주로 1개월 이내의 doubling time을 갖고 매우 빠르게 자라거나, 18개월이 넘는 doubling time을 갖고 매우 느리게 자랍니다. 1~18개월의 doubling time을 갖는 경우는 주로 악성 결절에 해당합니다.
- 5) 정답 선지

정답: 5)

해설

※23년 24번, 22년 30번 변형, 21년 26번 동일문제

- 1)~3)
- 석회화는 양성 결절에 더 흔히 나타나며, 양성 석회화 병변은 주로 diffuse, central, popcorn, laminated 모양을, 악성 결절 석회화는 주로 stippled, eccentric 모양을 보입니다.
- 4) 양성 결절은 주로 1개월 이내의 doubling time을 갖고 매우 빠르게 자라거나, 18개월이 넘는 doubling time을 갖고 매우 느리게 자랍니다. 1~18개월의 doubling time을 갖는 경우는 주로 악성 결절에 해당합니다.
- 5) 정답 선지

2023년 Q24 [김진영] 흉부질환의 영상의학 소견 유형분석

Q24. 24. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것이 악성 결절의 특징이다.
 - 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
 - 3) 악성 결절은 margin이 주로 smooth 한 양상이며 크기도 1cm미만으로 작은 것이 특징이다.
 - 4) 양성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated모양으로 나타난다.
 - 5) 양성 결절은 margin이 주로 lobulated, spiculated 한 양상이며 크기가 2cm이상으로 큰 것이 특징이다.
- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것은 양성 결절의 특징입니다.
 - 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 악성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징입니다(양성 결절은 너무 빠르거나 너무 느리게 자랍니다).
 - 3) 악성 결절은 margin이 주로 lobulated한 양상이며 크기는 2cm보다 큰 것이 특징입니다.
 - 4) 맞는 선지입니다.
 - 5) 악성 결절에 대한 설명입니다.

정답: 4

해설

2022학년도 호흡기 1차 30번과 동일합니다.

- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것은 양성 결절의 특징입니다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 악성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징입니다(양성 결절은 너무 빠르거나 너무 느리게 자랍니다).
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 lobulated한 양상이며 크기는 2cm보다 큰 것이 특징입니다.
- 4) 맞는 선지입니다.
- 5) 악성 결절에 대한 설명입니다.

2022년 Q30 [김진영] 흉부질환의 영상의학 소견 유형분석

Q30. 30. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것이 양성 결절의 특징이다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 smooth 한 양상이며 크기도 1cm미만으로 작은 것이 특징이다.
- 4) 양성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated모양으로 나타난다.
- 5) 양성 결절은 margin이 주로 lobulated, spiculated 한 양상이며 크기가 2cm이상으로 큰 것이 특징이다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 악성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징입니다(양성 결절은 너무 빠르거나 너무 느리게 자랍니다).
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 lobulated한 양상이며 크기는 2cm보다 큰 것이 특징입니다.
- 4) 맞는 선지입니다.
- 5) 악성 결절에 대한 설명입니다.

정답: 4

해설

- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것은 양성 결절의 특징입니다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 악성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징입니다(양성 결절은 너무 빠르거나 너무 느리게 자랍니다).
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 lobulated한 양상이며 크기는 2cm보다 큰 것이 특징입니다.
- 4) 맞는 선지입니다.
- 5) 악성 결절에 대한 설명입니다.

2021년 Q26 [김진영] 흉부 질환의 영상의학 소견 유형 분석

Q26. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적

소견 중 맞는 것은?

1) 양성 결절 석회화는 eccentric, stipple 한 것이 특징적이다.

이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천

2) 히 자라는 것이 특징이다.

악성 결절은 margin이 주로 spiculated, lobulated 한 양상이며 크기도

3) 2cm이상으로 큰 것이 특징이다.

4) 악성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated모양으로 나타난다.

악성결절은 calcification을 보이지 않으므로 calcification이 보일 경우 양성결절로 생각해야

5) 한다.

정답: 3

해설

1,4. 양성 결절 석회화는 central, laminated, popcorn 모양입니다. Eccentric, stipple한 것은 악성입니다.

2. Doubling time이 1~18개월인 것은 악성입니다. 양성은 <1 month or >18 months로 interval change 속도가 아주 빠르거나 느린 경우입니다.

3. 맞는 선지

5. Eccentric, stipple도 calcification입니다. Calcification이 있다고 해서 무조건 양성 결절인 것은 아닙니다.

원래 김진영 교수님은 선지만 조금씩 바뀌서 출제해오셨기 때문에 야마 선지 분석만 하면 충분했었습니다. 근데 올해는 24번 문제의 3번, 4번 선지처럼 아예 처음 보는 선지를 출제하셨네요. 또 25번 문제는 기존 야마가 실루엣 징후가 양성인지 음성인지 판단해서 병변 부위가 어디인지 찾는 것이었다면, 이번엔 더 나아가 폐렴인지 결핵인지도 구분해야 하는 문제였습니다. 게다가 26번 문제는 완전 처음 보는 문제였습니다. 앞으로는 김진영 교수님 파트 공부하실 때 야마는 기본으로 암기하고 강의록도 꼼꼼하게 봐야할 것 같습니다.

2020년 Q2 [김진영] 이차 폐소엽(Secondary pulmonary lobule) 및 흉부 CT 결절 분포 분류

Q2. 흉부 CT에서 이차 폐소엽(secondary pulmonary lobule)에 관한 설명으로 옳은 것은? (관련 CT 영상이 제시됨)

- 1) 그림은 일차 폐소엽(primary pulmonary lobule)을 나타낸 것이다.
- 2) 결절의 분포 양상에 따라 perilymphatic, random, centrilobular로 분류할 수 있다.
- 3) 소엽 중심 구조물(centrilobular structure)에는 폐정맥(pulmonary vein)과 이와 함께 주행하는 세기관지(bronchiole)가 포함된다.
- 4) Terminal bronchiole 분지 이후의 구조물로 정의된다.
- 5) 이차 폐소엽의 크기는 5~7 cm이다.

정답: 2

해설

흉부 CT에서 결절의 분포는 perilymphatic(림프관 주위), random(무작위), centrilobular(소엽 중심부) 세 가지로 분류되며, 이는 감별진단에 중요하다. ① 제시된 구조물은 이차 폐소엽(secondary pulmonary lobule, Miller's lobule)이다. ③ 소엽 중심 구조물에는 폐동맥(pulmonary artery)과 세기관지(bronchiole)가 포함되며, 폐정맥과 림프관은 소엽 간질(interlobular septa)에 위치한다. ④ Terminal bronchiole 이전 단계의 구조로, 이차 폐소엽은 terminal bronchiole을 포함하는 단위이다. ⑤ 이차 폐소엽의 크기는 약 1~2.5 cm(평균 약 2 cm)이며, 5~7 cm은 잘못된 수치이다.